初诊病史采集与查体

便携工作记录；相关阳性与阴性信息手写补充，正式记录依本院流程。

姓名 / 代号_____ 第二标识_____ 日期 / 时间_____

就诊诉求与现病史

相关背景 → 时间线 → 关键阳性 / 阴性；患者优先关切。
症状及影响；诱发 / 缓解因素；既往评估 / 治疗反应。

既往病史

诊断 / 并发症；专科诊疗；既往检查。
跌倒 / 意识丧失。

手术操作与重大医疗事件

手术 / 住院 / 急诊就诊；外伤；
装置 / 支持治疗；并发症。

用药史

处方药 / 非处方药 / 补充剂；实际使用 / 依从性 / 疗效；近期调整 / 用药差异。
相关用药详情；处方医生 / 药房 / 核实来源。

过敏与不良反应

相关药物或物质 / 反应 / 严重程度；无已知过敏、不明或未评估。

家族史

亲属关系 / 疾病 / 发病年龄；遗传模式。
如家族史不明，请注明。

社会背景与暴露史

居住 / 支持 / 资源可及性；职业 / 旅行 / 暴露；
烟酒及其他物质使用；饮食 / 活动 / 睡眠。

联系与转诊信息　联系方式_____ 基层 / 转诊医生_____

病史来源 / 可靠性 / 口译_____ 记录医生_____

参考框架：中国《医疗质量安全核心制度要点》（十八项核心制度）；美国 CMS 医院参与条件（CoPs）、Joint Commission 国家患者安全目标（NPSG；医院项目自 2026 年起由 NPG 取代）及 ACGME 住院医师培训通用要求（CPR）；英国 NICE CG50、NHS England / CPOC NatSSIPs；德国 G-BA QM-RL。
本模板参考上述框架中的相关原则，用于辅助初诊评估和住院患者管理，并支持临床思维与患者管理能力的培养和教学；不能替代医院 / 机构的正式病历、医嘱、管理系统或管理职责。

 © Junhui Liu M.D. 版权所有 反馈与支持：junhuiliu1025@gmail.com

病史查体与诊疗计划

如实记录发现；对当前需处理或尚不明确的问题详述推理。

姓名 / 代号_____ 第二标识_____ 日期 / 时间_____

记录医生_____ 补充病史来源_____

生命体征 血压_____ 心率____ 呼吸____ 体温____ 血氧/氧疗_____ 体重_____

系统回顾

全身 / 皮肤 / 头眼耳鼻咽喉 / 心血管 / 呼吸 / 消化 / 泌尿生殖；
肌肉骨骼 / 神经 / 内分泌 / 血液 / 淋巴 / 精神。

体格检查

一般情况 / 皮肤 / 头眼耳鼻咽喉 / 颈部 / 心肺 / 腹部；
四肢 / 肌肉骨骼 / 神经 / 精神状态 / 重点发现。

性与生育史

月经 / 绝经 / 妊娠；避孕 / 生育计划；
性伴侣 / 性行为 / 性传播感染史 / 防护。

功能与精神状态

日常活动 / 行动能力 / 跌倒；认知 / 情绪；
用药管理；安全 / 自伤风险。

预防接种核查

流感 / 新冠 / RSV；Td/Tdap；肺炎球菌 / 带状疱疹；
HPV / 乙肝 / 麻腮风 / 水痘；按风险或旅行需要接种。

预防保健核查

肿瘤；心血管 / 代谢；骨骼；HIV/HCV；
心理 / 物质使用。核对适用条件与既往结果。

关键检查结果与补充资料

关键检验 / 影像等；采样日期、单位、来源及临床意义；核对原报告。
重要异常：通知 / 处理 / 复评；缺失或待回报资料：负责人 / 下一步。

评估与诊疗计划

评估：优先问题 / 摘要 / 可能病因；支持与反对证据；重要鉴别 / 不确定性。
计划：检查 / 治疗 / 预期疗效；患者偏好与理解；复评 / 随访 / 再次就诊条件。
应变预案及需跟进事项按需续写；注明负责人、时限和联系方式。

参考框架：中国《医疗质量安全核心制度要点》（十八项核心制度）；美国 CMS 医院参与条件（CoPs）、Joint Commission 国家患者安全目标（NPSG；医院项目自 2026 年起由 NPG 取代）及 ACGME 住院医师培训通用要求（CPR）；英国 NICE CG50、NHS England / CPOC NatSSIPs；德国 G-BA QM-RL。
本模板参考上述框架中的相关原则，用于辅助初诊评估和住院患者管理，并支持临床思维与患者管理能力的培养和教学；不能替代医院 / 机构的正式病历、医嘱、管理系统或管理职责。

 © Junhui Liu M.D. 版权所有 反馈与支持：junhuiliu1025@gmail.com